

NS		Parkinson	
PAULO RUBENS LANCIA CURY			
IDADE: 68 anos	PESO: 72	ALTURA: 1,72	PROFISSÃO: Engenheiro.
SINTOMAS: sonolência; sono;			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS: Prolopa; Azilect; glicage (DM); - fardicome;			
Benicou (HAS);			
MÉDICO: Dr. Paulo Maurício Chagas Bruno (gato) / Carlos Dra. Takanen			
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada todos os dias / pilates 2x			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 23h30'		HORA QUE ACORDA: 6h30'	
COCHILLO (X)SIM ()NÃO 30'		DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA ()NÃO		FDS - 2 vezes.	
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO: 4x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: III	IAH: 47,4 e/h	SPO2: 98%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: ()NASAL ()AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (S)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA			
(N)ORTOPÉDICA (S)NEUROLÓGICA ()OUTROS			
28/06/2023		Avaliação - Início cap.	
Resmed Auto		4 a 15 cmH2O	
		EPR = 1 rampa	
		umidif 4	
05/07/2023		P = 6,3 cmH2O P90: 8,3 cmH2O	
		IAH = 1,2	
		m de uso = 6h15' min.	
13/07/2023		P = 6,2 cmH2O P90: 7,4	
		IAH = 1,0 e/h	
		m de uso = 5h40' min	
		fuga = 18,6 l/min	
		→ não disposto	
		* para pressão fixa P = 6,4 cmH2O	
19/07/2023		P = 6,4 cmH2O	
		IAH = 1,3 e/h	
		m de uso = 6h30'	
		fuga = 17,5 l/min	
		→ não disposto	
02/08		P = 6,4 cmH2O	
23		m. de uso: 6h	
		melhoria da dispnoia e sonolência.	
		Fuga: 0,4 l/min.	
17/08		P = 6,4 cmH2O	
23		IAH = 1,6 e/h	
		m de uso: 6:23'	
		Bem adaptado	
		fuga.	

15/09/23 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 1,4 e/h
m. de uso: 6h44'
fuga: 12 l/min.

- mais disposto
P inicial: 4
APE só rompa: 3
umidif: 4 slim line

16/09/23 P= 6,4
IAH: reiniciou hoje.

lua

06/03/23 P= 6,4
mantém uso do CPAP, indo dormir muito tarde

lua

15/03/23 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 0,6 e/h
m. de uso: 5m
Bem adaptado,

relata manter exerc. físico. lua.

21/05/24 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 1,7
m. de uso: 4h24'
Fez cirurgia de catarata.

sono agitado no início do sono.

lua

22/07/24 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 1,1 e/h
M. de uso: 2h54'
Bem adaptado

Relata estar dormindo mal,
e o sono do dia de 30'.

lua

26/08/24 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 1,2 e/h
m. de uso: 2h25'

marbã - caminhada
2x4a - funcional
2x - pilates

26/09/24 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 1,3
M. de uso: 3h41'
fuga: 12,3 lpm

lua

04/10/24 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 0,8 e/h
M. de uso: 3h35'

Belecalme p/ manter o sono.
relata que às 00:00 teve uma
moda q/ formigamentos, depois
dorme. lua.

13/01/25 P= 6,4 cmH₂O
IAH = 0,8 e/h
m. de uso: 1h21'
fuga: 1,9 lpm

Oriento o uso constante.

lua

05/03/25 P=6,4 cm H₂O
IAH=3,0
medic: 1h37'
fuso: 3,5 l/m

Relata estar se
adaptando

Natacha

03/04/25 [23 - 23:30 - início do sono
6 - acorda

18hs - faz exercício físico *

Claustrofobia - nasceu por fórceps.

15/05 - não posso estar alt. a medicação - fuso

16/07/25 P=6,4 cm H₂O - teve pico de ansiedade
IAH=0,9 e/lv - mudança de medicação
M. de uso: 1h10' agora
- laminada 7-8 h.

Pedi p/ sair de dentro de casa — fuso

CLÍNICO
DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Paulo Rubens Lancia Cury

EXAME nº: 5308

SOLICITADO POR: Dr. Paulo Maurício Chagas Bruno

DATA: 09/02/2023

IDADE: 68 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h57min e concluído às 06h00min. A latência para o sono foi de 5 minutos e a latência para o estágio REM, de 82 minutos. O tempo total de sono foi de 315,5 minutos (05h15min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 75,8%. A distribuição do sono registrado mostrou 28,5% de estágio 1, 45,3% de estágio 2, 14,4% de estágio 3 e 11,7% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 95 minutos em vigília, ocorreram 168 microdespertares (índice: 31,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 10,6/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 47,4/hora, sendo 12,2 apneia/hora e 35,2 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 47,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 92% e a mínima de 78%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (47,4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (47,4/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 46; máxima: 60 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 5 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (82 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 75,8%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 31,9/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (28,5%; normal: 8-10%) e 3 (14,4%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (11,7%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (45,3%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros permaneceu no limite da normalidade (10,6/hora; índice normal até 15/hora).

Escala de Sonolência de Epworth: 10 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

À Dr Ana Claudia (Fisioterapia especializada em sono)

Paciente PAULO RUBENS LANCIA CURY portadora de apneia do sono com AIH >30

Portador de doença de Parkinson

Solicito avaliação para BIPAP

Att

Dr alexandre coelho marques
Neurologista

17/11/21

Dr Ana Claudia : 12 - 99724-7053

Dr. Alexandre C. Marques
Neurologista
CRM-SP 146.146

Dr Alexandre Coelho Marques
CRM: 146.146
Neurologista
22/05/2023